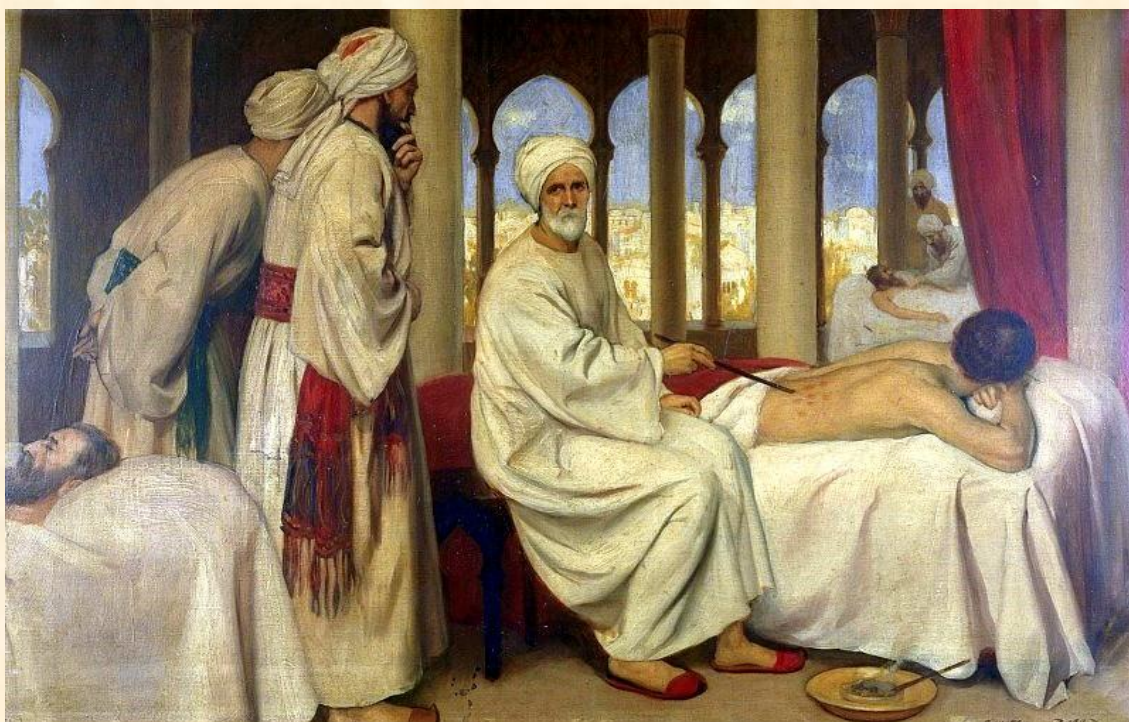


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



*«Η καλή υγεία είναι μια κορώνα στο κεφάλι των υγιών,
που μόνον αυτοί που είναι άρρωστοι μπορούν να δουν».*

Αραβική παροιμία.

ΚΟΛΙΚΟΣ ΟΥΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ

Γενικά: Η κυριότερη αιτία του κολικού είναι η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος. Συνήθως προκαλείται από μικρού μεγέθους λίθους, τόσο μικρούς που δεν εντοπίζονται με τα συνήθη απεικονιστικά μέσα, όπως ακτινογραφία (α/α ΝΟΚ) ή υπερηχογράφημα (U/S).

Αναλόγως της εντόπισης των λίθων, περιγράφεται λιθίαση των νεφρών (νεφρολιθίαση), λιθίαση των ουρητήρων, λιθίαση της ουροδόχου κύστης και τέλος λιθίαση της ουρήθρας. Πολλοί λίθοι, όπως οι εντοπιζόμενοι στους κάλυκες του νεφρού, είναι ασυμπτωματικοί.

Οι λίθοι της ουροδόχου κύστεως μπορεί να προκαλέσουν στραγγουρία (ατελέσφορο αίσθημα επιθυμίας για ούρηση), ενώ λίθοι της ουρήθρας προκαλούν διακοπή της ούρησης.

Το μέγεθος, αλλά και η θέση των ουρολίων, παίζουν σημαντικό ρόλο για τη μετέπειτα αντιμετώπιση. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, λίθοι με διάμετρο < 5 mm αποβάλλονται αυτόματα με την ούρηση, σε ποσοστό 90%, ιδιαίτερα αν βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα του ουρητήρα, προς την ουροδόχο κύστη. Κατά συνέπεια, εφόσον αντιμετωπιστούν και υποχωρήσουν τα οξέα συμπτώματα, μπορεί κανείς να περιμένει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (περίπου έως έναν μήνα) για την αποβολή του λίθου με την ούρηση.

Το 75% των περιπτώσεων νεφρολιθίασης οφείλονται σε λίθους ασβεστίου (30-35% οξαλικού, 5-10% φωσφορικού και 35% μεικτοί λίθοι). Η συχνότερη αιτία δημιουργίας τους είναι η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία. Άλλες αιτίες ουρολιθίασης, θεωρούνται ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, η υπερουρικοζουρία, η υποκιτρικουρία, η υπεροξαλουρία (από την αυξημένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε οξαλικά άλατα, όπως: σπανάκι, μαϊντανός, γλυκοπατάτα, σέσκουλο, πιπεριές, παντζάρια, μπάμιες, ακτινίδιο, σόγια, ραβέντι, φαγόπυρο, σοκολάτα, κακάο, φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα, κ.ά.).

Ιστορικό: Η οικογενειακή προδιάθεση διαδραματίζει έναν ρόλο, αφού 25% των ασθενών με υποτροπιάζοντα κολικό έχουν οικογενειακό ιστορικό, ενώ ο κίνδυνος για την εμφάνιση στο μέλλον λιθίασης είναι τρεις φορές μεγαλύτερος όταν υφίσταται αντίστοιχο ιστορικό.

Αναλογία άνδρες/γυναίκες: 4/1. Ελέγχουμε τα επίπεδα ουρικού οξέος ή πιθανή συνύπαρξη υπερπαραθυρεοειδισμού, φλεγμονώδους νόσου του εντέρου -δυσασπορρόφηση, ειλεοστομία, λήψη φαρμάκων, ΣΔ, σύνδρομο Sjögren, Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση, κακοήθεια, κ.ά.

Κλινική εξέταση: Έλεγχος ζωτικών σημείων (ΑΠ, HR, SpO₂, Θ) κι έλεγχος για συνύπαρξη κακουχίας και υψηλού πυρετού με ρίγος (έναρξη, ύψος πυρετού, διακύμανση, υφέσεις).

Ψηλάφηση κοιλίας. Έλεγχος του σημείου Giordano. Διερευνούμε για αποφρακτικού τύπου πυελονεφρίτιδα. Η φλεγμονώδης λιθίαση οφείλεται συνήθως σε ανάπτυξη βακτηρίων που παράγουν ουρεάση (*Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Pseudomonas sp.*) και Εντερόκοκκους. Το *E. coli* - που αποτελεί συχνό αίτιο ουρολοιμώξεων - δεν παράγει φλεγμονώδεις ουρολίθους.

Εργαστηριακά: Γενική αίματος: Έλεγχος, για λευκοκυττάρωση (WBC > 11000/μl).

Βασικός Β/Χ έλεγχος: Glu, Urea, Creat., CRP και ό,τι άλλο ίσως χρειαστεί, επί ενδείξεων.

Stick ούρων - γενική ούρων: έλεγχος pH, έλεγχος για αιματουρία, πυουρία και νιτρικά.

Διαφορική διάγνωση: Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ), περισφιγμένη βουβωνοκήλη, επιδιδυμίτιδα, συστροφή όρχεως, έκτοπη κύηση, σαλπινγίτιδα, κρίση δρεπαν/κής αναιμίας, οξεία σκωληκοειδίτιδα, κρίση ΙΦΝΕ ή ΣΕΕ, έρπης ζωστήρας, μυοσκελετικό άλγος, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Καθησυχάζουμε τον ασθενή κι ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T °C). Επί ενδείξεων ή σε συννοσηρότητα από το καρδιαγγειακό διενεργείται ΗΚΓ, ενώ επί υποψίας ουρολοίμωξης εκτελούμε γενική αίματος, βασικό Β/Χ έλεγχο και γενική ούρων.
2. Σε ορό 100-250 ml N/S τοποθετείται ΜΣΑΦ (1 amp. Dynastat 40 mg ή Xefo 8 mg), όπως και 1 fl. 100 ml Apotel 1 gr και 1 amp. Buscopan 20 mg (ή 1 amp. Spasmo-apotel, im), Εναλλακτικά, χορηγείται 1 fl *Combogesic* (1 g/300 mg), σε έγχυση εντός 10-15 λεπτών. Για γαστροπροστασία 1-2 amp. Σιμετιδίνη 200 mg (Tagamet) σε 100 ml N/S (στάγδην).
3. Εναλλακτικά, χορηγούνται ενδομυκώς (im) 1 amp. ΜΣΑΦ (Voltaren/Dynastat/Viaxal), μαζί με 1 amp. Apotel-plus (600/20) mg και προαιρετικά και 1 amp. Buscopan 20 mg.

Αν, μετά από παρέλευση 45-60 λεπτών, ο πόνος επιμένει:

- ▶ Αφού επιτύχαμε φλεβική πρόσβαση· σε ασθενείς νέους με υγιές καρδιαγγειακό σύστημα αρχίζουμε με χορήγηση 250-500 ml NaCl 0,9% και 1-2 amp. Buscopan* 20 mg (iv στον ορό) εντός 30-45 λεπτών και συνεχίζουμε με τη χορήγηση 500 ml NaCl 0,9% σε συνεχή στάγδην έγχυση για τα επόμενα 45-60 λεπτά, για ενυδάτωση και ευόδωση διούρησης.
- ▶ Για τον περιορισμό του έντονου άλγους και της δυσπραγίας του ασθενούς, μπορούμε να χορηγήσουμε 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνης 75 mg (Zideron/Romidon) (im) ή βραδέως ενδοφλεβίως σε ορό 100 ml N/S ή χορηγούμε ½ - 1 amp. Πεθιδίνης (im) κάθε 3-4 ώρες. Εναλλακτικά, επί έντονου πόνου, χορηγείται Τραμαδόλη (1 amp. Tramal, im ή αργά iv).

* Η Υοσκίνη (αντιχολινεργικό) αντενδείκνυται σε ΚΥΠ, ειλεό, γλαύκωμα, ταχυαρρυθμίες, μυασθένεια, κ.ά.

Αγωγή κατ' οίκον:

Η θεραπεία της μη επιπλεγμένης νεφρολιθίασης στην οξεία φάση της, εκτός από την ανακούφιση των συμπτωμάτων, στοχεύει στην διευκόλυνση της μετακίνησης του λίθου και της αποβολής του με τα ούρα. Η **αναλγητική αγωγή** και η **επαρκής ενυδάτωση** είναι τα αρχικά θεραπευτικά μέτρα. Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να εφαρμοστεί και κατ' οίκον, εφόσον είναι δυνατή η από του στόματος λήψη φαρμάκων και η ενυδάτωση κι εφόσον φυσικά η νεφρολιθίαση δεν επιπλέκεται με οξεία πνευμονεφρίτιδα ή οξεία νεφρική βλάβη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρειάζεται νοσοκομειακή αντιμετώπιση και φροντίδα.

1. Χορηγούμε ένα ΜΣΑΦ, για 3-5 ημέρες, αναλόγως της περιπτώσεως, π.χ.:
 - tab. Xefo rapid 8 mg, 1x2 τις πρώτες 2 ημέρες και 1x1 για άλλες 3 ημέρες, ή
 - tab. Mesulid 100 mg, 1x2 τις πρώτες 2 ημέρες και 1x1 για άλλες 3 ημέρες.
2. Χορηγούμε Παρακεταμόλη· προαιρετικά μαζί με ένα σπασμολυτικό (όχι σε ΚΥΠ), π.χ.:
 - tab. Spasmo-Apotel ή Buscopan-plus (10/500) mg, 1x3 ή 1x2, για 3-5 ημέρες.
3. Ιδιαίτερη προσοχή στη γαστροπροστασία (ελκοπαθείς, ηλικιωμένοι, κ.ά.), χορηγώντας Ρανιτιδίνη/Φαμοτιδίνη (Zurfix/Peptan 1x2) ή PPIs (Losec/Nexium 1x1), για 5-7 ημέρες.
4. Αν συνυπάρχει ουρολοίμωξη ή βάσιμη κλινική υποψία της, χορηγούμε per os αντιβίωση αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων της περιοχής, του φύλου και του ιστορικού του/της ασθενούς (βλ. *εδάφια: οξεία κυστίτιδα & οξεία πνευμονεφρίτιδα, σελ. 217 & 220*).
5. Η χρήση α-αποκλειστών [Tamsulosin (Omnice 0,4 mg), Silodosin (Silodyx 8 mg)] per os θεωρείται πιθανώς ικανή στην υποβοήθηση της διέλευσης του λίθου, μειώνοντας τον βασικό τόνο, την περισταλτική συχνότητα και την ουρητηρική συσπαστικότητα, μέσω της δράσης στους α₁-αδρενεργικούς υποδοχείς των ουρητηρικών λείων μυϊκών ινών.
6. Συστήνεται στον ασθενή, η τοποθέτηση θερμών επιθεμάτων στην οσφύ (π.χ. *θερμοφόρα*) κατά την κατάκλιση, για την ανακούφιση, τοπικά, από τον πόνο και τη δυσφορία.

Διατροφικές οδηγίες, με προεξάρχουσα την αποφυγή λήψης αλκοόλ και αναψυκτικών. Περιορισμός των πλούσιων σε οξαλικά τροφών και υγρών. Ο περιορισμός των τροφών που περιέχουν ασβέστιο, κρίνεται ως μια αμφιλεγόμενη τακτική. Η ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου φάνηκε ότι δεν ωφελεί στην πρόληψη των υποτροπών των κολικών από λίθους ασβεστίου και μάλιστα μπορεί να είναι και επιζήμια, λόγω της ανισορροπίας στο ισοζύγιο μετάλλων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ισορροπία με το ασβέστιο των οστών. Προτείνεται η **λήψη άφθονων υγρών** (κυρίως νερό και ροφήματα), ώστε να εξασφαλίζεται αποβολή ούρων άνω των 2 λίτρων ημερησίως, ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες.

7. Οι ασθενείς με ουρολίθους από ασβέστιο ωφελούνται αρκετά από τη λήψη θειαζιδικών διουρητικών, που μειώνουν το ασβέστιο ούρων. Ωστόσο, απαιτείται η χρήση θειαζιδίων για 2 χρόνια, ώστε να φανεί η ευεργετική επίδρασή τους στην υποτροπή των λίθων.
8. Σε ασθενείς με ουρολίθους ουρικού οξέος επιδιώκουμε ρύθμιση της υπερουριχαιμίας, με διατροφικές οδηγίες (βλ. *σελ. 409*) ή με χορήγηση Αλλοπουρινόλης ή Φεμπουξοστάτης.
9. Επί συχνών υποτροπών, παραπέμπουμε για ακτ/φία NOK και για U/S ουροφόρων οδών. Η ευαισθησία των υπερήχων όσον αφορά στην ανάδειξη λιθίασης είναι περίπου 40-65%.